

O COMPOSER utiliza *conformal prediction* para classificar certos casos como “indeterminados”. Como é que isso afeta o equilíbrio entre sensibilidade clínica e risco de alert fatigue num ambiente real?

Essa pergunta significa basicamente isto:

- **Sensibilidade clínica** = capacidade do sistema detetar corretamente casos graves (ex.: sépsis verdadeira). Quanto maior a sensibilidade, menos casos perigosos escapam.
- **Alert fatigue** = quando o sistema gera demasiados alertas, muitos deles falsos ou irrelevantes, e os profissionais começam a ignorá-los.

Ou seja, a pergunta quer explorar este dilema:

“Se aumentarmos muito a sensibilidade do sistema para não falhar casos graves, não vamos também aumentar o número de alertas e cansar os profissionais?”

Podes reformular a pergunta de forma mais natural/oral assim:

- “No COMPOSER, como é que eles conseguem evitar excesso de alertas sem perder capacidade de detetar casos graves?”
- “Até que ponto aumentar a sensibilidade do modelo pode criar alert fatigue nos profissionais?”
- “Acham que o equilíbrio entre detetar mais casos e evitar alertas excessivos foi bem conseguido no COMPOSER?”

Pergunta 2-Acham que modelos treinados em hospitais académicos conseguem manter desempenho semelhante em hospitais periféricos com menos recursos e datasets menos completos?

Pergunta 3-No COMPOSER, os scores são atualizados hora a hora. Em situações críticas, isso pode ser insuficiente. Acham viável sistemas com inferência contínua em streaming? Que impacto teria ao nível computacional e operacional?

Pergunta 4- Como já referido muitas vezes pelo professor ,tendo em conta que em contexto clínico uma precisão de 70-80% pode ser insuficiente, até que ponto estes SSD são realmente seguros para apoiar decisões médicas críticas?